

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA BASAL

Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA

Sexo: Feminino

Data do Exame: 31-05-2025

Idade: 78 anos

Peso: 79 kg

Altura: 1,56 m

Médico Solicitante: DR. PEDRO HENRIQUE DE ABREU
MACEDO

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 31/05/2025 22:05 e finalizado às 01/06/2025 05:43.

A latência para início do sono foi de **49,0** min e a latência para o sono REM de **88,5** min.

O tempo total de sono (TTS) foi de 389,0 min, com eficiência do sono de **85,0** %.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **6,4** % de estágio N1, **53,7** % de estágio N2, **12,6** % de estágio N3 e **27,2** % de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 19,7 min. Ocorreram 61 despertares, sendo o índice de **8,0 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **0,0 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 167, sendo 9 apneias obstrutivas, 1 apneia centrais, 0 apneias mistas, 157 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **25,8 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 40,8 e o IDR durante o sono NREM foi de 20,1. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 25,8 (nº/h), sendo 1,5 apneia/h e 24,2 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 91%, a **média** de 90% e a **mínima** de 80%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 21,5 (nº/h), sendo que em REM foi de 41,3 (nº/h) e em NREM foi de 19,3 (nº/h). Permaneceu 28,2 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (0), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (**25,8 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (**80%**);
3. Latência para o início do sono (**49,0 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (**88,5 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (**85,0 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares **8,0 n°/h** (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (**6,4 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (**53,7 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (**12,6 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (**27,2 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco verificado via sensor de ronco;

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

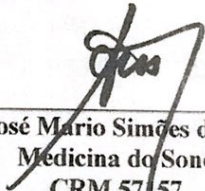
Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.157

INDICADO POR:

() ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

MARIA APARECIDA DA SILVA

IDADE: 88 PESO: ALTURA: 156 PROFISSÃO: Adm da Sta Casa / Apos.

SINTOMAS: MMII edemaciado / Refluxo gástrico / Cansaço
Cabeça pesada

QUEIXAS: Dificuldade p/ dormir / esquecida

MEDICAMENTOS: Ferro / Rosuvastatina / Benerva / cloridrato
duloxetine / Puranti

MÉDICO: Dr. Pedro Marcelo DLE * Aparelho auditivo

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: 3x pilates

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 5 (18h)

HORA QUE DORME: 23:30 HORA QUE ACORDA: 8:30 - 9:00

COCHILO () S ☒ N DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTETEM FILHOS: ☒ S () N / DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N PET NO QUARTO: () S ☒ NBEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N as vezes vinho

FUMO: () S () MAÇO/DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 4x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 4 CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: Asuwa MALLAMPATI: IAH: SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Dor na coluna

marido fumava no quarto / Fegão a esquerda (DPOC)
Dormir e latir muito

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: - 3 cesáreas / apendicite

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ N SPO2 C/ CPAP: - PRESSÃO NO EXAME: -

20/08 Fica celular às vezes

25 Faz leitura